

Infecciones Fúngicas — Dermatofitosis, Candidiasis cutánea y Pitiriasis versicolor

1. Introducción y relevancia clínica

Las **infecciones fúngicas cutáneas**, también llamadas **micosis superficiales**, son extremadamente frecuentes en la práctica clínica, representando **hasta el 20% de las consultas dermatológicas**.

Afectan las capas más externas de la piel, uñas y pelo, y se producen por **hongos dermatofitos, levaduras del género Candida o Malassezia**.

Su relevancia radica en:

- Su **alta transmisibilidad**, especialmente en ambientes cálidos y húmedos.
- La **recurrencia** en pacientes con comorbilidades (diabetes, inmunosupresión, obesidad).
- La **necesidad de diagnóstico diferencial** con patologías inflamatorias (eczema, psoriasis).
- La **frecuencia en el EUNACOM**, especialmente tiña pedis, tiña corporis y candidiasis intertriginosa.

El diagnóstico es fundamentalmente **clínico**, pero debe **confirmarse con examen directo con KOH o cultivo micológico**, para evitar tratamientos erróneos con corticoides tópicos.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Dermatofitos

- Hongos **filamentosos queratinofílicos**, que degradan queratina y afectan **estrato córneo, pelo y uñas**.
- Géneros principales: **Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton**.
- Se transmiten por contacto directo humano, animal o fómites.
- **No invaden tejidos profundos** en inmunocompetentes.

2.2. Levaduras (Cándida)

- *Candida albicans* es comensal del tubo digestivo y mucosas.
- Se vuelve patógena ante humedad, maceración, inmunosupresión o disbiosis.
- Produce infecciones en **pliegues, mucosas y uñas**.

2.3. Levaduras lipofílicas (*Malassezia furfur*)

- Flora normal del cuero cabelludo y tronco.
- Bajo calor y humedad, prolifera y genera **pitiriasis versicolor**.
- Su patogenicidad depende de la **conversión de levadura a forma micelial**.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Dermatofitosis (Tiñas)

Las tiñas se denominan según la **localización anatómica**:

Localización	Nombre	Agente más común	Características clínicas
Cuero cabelludo	Tinea capitis	<i>Microsporum canis</i> , <i>Trichophyton tonsurans</i>	Placas alopécicas con descamación, pelos rotos ("puntos negros"), adenopatías occipitales.
Cuerpo	Tinea corporis	<i>Trichophyton rubrum</i>	Placas eritemato-descamativas con borde activo y centro claro ("en anillo").
Ingle	Tinea cruris	<i>T. rubrum</i> , <i>E. floccosum</i>	Placas eritemato-descamativas pruriginosas en pliegues inguinales. Respeta escroto.

Pies	Tinea pedis	<i>T. rubrum</i> , <i>T. mentagrophytes</i>	Interdigital (fisuras, maceración), plantar (hiperqueratósica) o vesicular.
Uñas	Tinea unguium / Onicomycosis	<i>T. rubrum</i>	Engrosamiento, coloración amarilla o marrón, fragilidad ungueal.

Síntomas

Prurito, descamación, bordes activos y cronificación si no se trata.

Diagnóstico diferencial

- Eczema numular, psoriasis, dermatitis seborreica.
- En uñas: psoriasis ungueal, trauma, liquen plano.

3.2. Candidiasis cutánea y mucocutánea

Etiología

C. albicans (>80%) y otras especies (*glabrata*, *tropicalis*).

Afecta áreas húmedas e intertriginosas.

Factores predisponentes

- Calor y humedad.
- Diabetes mellitus.
- Obesidad y uso de ropa ajustada.
- Uso prolongado de antibióticos o corticoides.
- Inmunosupresión o embarazo.

Formas clínicas

Tipo	Localización	Características
Intertrigo candidiásico	Pliegues (submamarios, inguinales, axilares)	Placas eritematosas con bordes macerados y pústulas satélite .
Candidiasis oral (muguet)	Mucosa oral, lengua	Placas blanquecinas removibles, eritema subyacente.
Queilitis angular	Comisuras labiales	Fisuras dolorosas bilaterales.
Paroniquia / onicomicosis por Candida	Pliegues ungueales	Eritema, edema, supuración, pérdida de cutícula.
Candidiasis genital	Vulva, pene	Prurito, flujo blanco grumoso, eritema.

Diagnóstico diferencial

- Tiña cruris o eczema en pliegues.
- Psoriasis invertida (lesiones bien delimitadas, sin satélites).
- Eritrasma (fluorescencia rojo coral en luz de Wood).

3.3. Pitiriasis versicolor

Etiología

Levadura lipofílica *Malassezia furfur*.

Fisiopatología

Conversión a forma micelial en condiciones de calor, humedad o inmunosupresión → colonización superficial del estrato córneo.

Clínica

- Máculas hipopigmentadas, hiperpigmentadas o eritematosas, con **descamación fina tipo “harina”**.
- Localización: **tronco superior, cuello, hombros, parte proximal de brazos**.
- Asintomática o pruriginosa leve.
- **Recaídas frecuentes** en verano.

Diagnóstico diferencial

- Vitiligo (áreas acrómicas con bordes netos, sin descamación).
- Pitiriasis alba (en niños, facial).
- Leucodermias postinflamatorias.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

Examen	Utilidad	Hallazgo característico
Raspado con KOH (10–20%)	Confirmar tiñas y candidiasis	Hifas tabicadas (dermatofitos), pseudohifas y blastoconidios (Candida)
Cultivo en agar Sabouraud	Identificación de especie	Colonias blancas o algodonosas
Luz de Wood	Diagnóstico de pitiriasis versicolor	Fluorescencia amarillo-verde
Tinción PAS (histología)	Confirmar hongos en biopsia	Hifas magenta en estrato córneo

Examen directo con tinta Parker o azul de metileno	Pitiriasis versicolor	“Espaguetis y albóndigas” (hifas cortas y esporas redondas)
---	-----------------------	---

El diagnóstico es **confirmatorio con KOH positivo**, aunque en la práctica clínica, la mayoría se trata empíricamente.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

5.1. Dermatofitosis

Localización	Tratamiento	Duración
Tiña corporis / cruris / pedis leve	Antifúngico tópico: terbinafina 1%, clotrimazol 1%, ketoconazol 2% (2 veces/día)	2–4 semanas
Tiña extensa o refractaria	Terbinafina VO 250 mg/día o itraconazol 100 mg/día	2–4 semanas
Tiña capitis	Griseofulvina VO 10–20 mg/kg/día (niños) o terbinafina 250 mg/día (adultos)	6–8 semanas
Onicomycosis	Terbinafina VO 250 mg/día o itraconazol 200 mg/día (pulsos)	3–6 meses (uñas manos), 6–12 (pies)

❑ **Nota:** Las tiñas no responden a corticoides tópicos; su uso puede causar **tiña incógnita** (lesiones atípicas y diseminadas).

5.2. Candidiasis

Tipo	Tratamiento tópico	Tratamiento sistémico
------	--------------------	-----------------------

Cutánea / Intertrigo	Clotrimazol, miconazol o nistatina 2 veces/día	Fluconazol 150 mg VO semanal o itraconazol 100 mg/día × 7–14 días
Oral (muguet)	Nistatina en suspensión 4 veces/día	Fluconazol 100 mg/día × 7–14 días
Vaginal	Óvulos de clotrimazol / miconazol por 3–7 días	Fluconazol 150 mg VO dosis única
Paroniquia	Evitar humedad + antifúngico tópico	Fluconazol 150 mg/sem por 2–4 sem

Medidas generales:

Mantener piel seca, evitar ropa ajustada, controlar diabetes, suspender corticoides o antibióticos innecesarios.

5.3. Pitiriasis versicolor

Tratamiento tópico	Alternativas sistémicas	Duración
Ketoconazol 2% o terbinafina 1% crema / shampoo	Itraconazol 200 mg/día × 5 días o fluconazol 300 mg/sem × 2 sem	1–4 semanas
Shampoo de sulfuro de selenio 1–2.5%	—	Aplicar 10 min/día por 7 días

Prevención de recurrencias:

Aplicar shampoo antifúngico (ketoconazol o selenio) 1 vez/semana por 3 meses.

6. Complicaciones y pronóstico

Patología	Complicaciones	Pronóstico
Tiñas	Sobreinfección bacteriana, diseminación o tiña incógnita	Excelente con tratamiento adecuado
Candidiasis	Cronificación o diseminación sistémica en inmunodeprimidos	Excelente en formas cutáneas
Pitiriasis versicolor	Recidivas frecuentes, alteraciones pigmentarias persistentes	Muy bueno, autolimitada

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. **Tiña corporis:** placa anular con **borde activo descamativo y centro claro**.
2. **Candidiasis intertriginosa:** bordes macerados con **pústulas satélite**.
3. **Pitiriasis versicolor:** máculas hipo/hiperpigmentadas con **descamación fina y fluorescencia verdosa**.
4. En **tiña capitis**, los pelos rotos ("puntos negros") son diagnósticos.
5. El examen con **KOH** es el estándar para confirmar micosis.
6. En onicomycosis, tratar solo tras confirmación micológica (dura meses).
7. En EUNACOM, las preguntas suelen contrastar **tiña vs dermatitis de contacto**.



Errores comunes

- Usar **corticoides tópicos** en tiñas (empeoran cuadro).

- Diagnosticar candidiasis solo por eritema sin satélites.
 - Tratar pitiriasis versicolor con antibióticos tópicos.
 - No tratar convivientes o fuentes de reinfección (animales, fómites).
 - Suspender tratamiento antifúngico antes del tiempo indicado.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Las infecciones fúngicas cutáneas se clasifican en **dermatofitosis, candidiasis y pitiriasis versicolor**.
2. El diagnóstico se confirma con **examen directo con KOH** (hifas o levaduras).
3. El tratamiento de elección son los **antifúngicos tópicos** (clotrimazol, terbinafina).
4. Las tiñas profundas o ungueales requieren **tratamiento oral prolongado**.
5. En candidiasis, buscar **factores predisponentes sistémicos** (diabetes, humedad).
6. La **pitiriasis versicolor** recurre frecuentemente; se previene con shampoo antifúngico semanal.
7. Evitar corticoides tópicos en micosis: producen **tiña incógnita**, diagnóstico clásico en EUNACOM.